

WD8737500BAG1

H 370959727CE8

IME 26.1

X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS J369821218B30

FRANCISCO EUGENIO DE OLIVEIRA CRUZ

IDADE: 65a. PESO: 81 ALTURA: 1,75 PROFISSÃO: Operador - Aposentado

SINTOMAS:

QUEIXAS: Esposa reclama do ronco - Ansiedade

MEDICAMENTOS: Pressat / Hara 2 / Zetia / Rosucor.

HAS / colesterol

MÉDICO: Dr^a Priscila / Dr^a Flávia

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Faz exercício físico / mas muito ativo.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: - JANTAR: S

HORA QUE DORME: ~~n tem hora~~ HORA QUE ACORDA: 6 - 7 horas

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO Masc. Dream

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: - Wear Pillow

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 50,3 e/e/SPO2: 85%, mínima

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não Desaturação: 50,7/94% média

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Tempo em apnéia: 27,7 med.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não 50,0 mais

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor ombro (E)

20/03/24 - Avaliação.

05/10/24 ajuste o CPAP e máscara.

15/10/24 P=5,7 cmH₂O - Pte relata não conseguir
IAH=8,6 e/e/h dormir, dificuldade
m. de uso: 4h71 na expiração e a máscara
fuga: 24,38/m
Natacha

29/10/24 P=5,5 cmH₂O 1 ajuste 5-8,5 cmH₂O
IAH=5,8 e/e/h
m. de uso: 6h59' Utilizando por mais
fuga: 9' tempo, melhor adaptada
Natacha

28/11 P=6,4 cmH₂O - Relata ir ao banheiro
24 IAH=6,5 e/e/h 2x por noite.
m. de uso: 8h - Começou a dormir 22h.
fuga: 12'

06/02 P=6,7 cmH₂O
25 IAH=5,4 2x ao banheiro
fuga=12'
m. de uso: 8h20'
fuga: 12'

13/05
25

$P = 5,6 \text{ cm H}_2\text{O}$

$IAH = 4,8 \text{ e/h}$

medida: 7h30'

fuga: 25'

Bem adaptado

Natasha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: FRANCISCO EUGENIO DE OLIVEIRA CRUZ			
Sexo: M	Idade: 63 anos	Peso: 80 Kg	Altura: 1,75 m
IMC: 26,1	Data do Exame: 18/10/2022	Exame: 00065_01	
Médico solicitante: DRA FLAVIA			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 20:55:08 horas e encerrado às 06:02:13 horas, com latência para o sono de 101 minutos e latência para o sono REM de 212 minutos. O tempo total de sono foi de 354,0 minutos, com eficiência do sono de 64,5%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,6%	Até 5%
Estágio 2	79,0%	45 - 55%
Estágio 3	13,7%	> 15%
Sono REM	5,8%	20 - 25%
Eficiência do sono	64,5%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WASO 153,5 minutos ocorreram 345 despertares (índice de 58,5 /hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 77 bpm, a maior de 112 bpm e a menor de 61 bpm.

Foram identificados 0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.

Ocorreram 297 eventos respiratórios, sendo 0 central, 297 obstrutivos e 0 misto. Sendo 251 apnéias, 46 hipopnéias e 0 RERAS. O Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 50,3/hora, sendo 42,5 apnéia/hora e 7,8 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 27,6 e a duração máxima de 50,4.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 93,7/hora, sendo 93,7 apnéia/hora e 0,0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%, sendo a saturação média de 94%, a maior de 99% e a mínima de 85%, permanecendo 3,1 minutos (0,6%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0,0 minutos (0,0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 299 dessaturações. Índice de dessaturações: 50,7/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 94,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 48,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Guilherme Salomon de Domicis
 Otorrinolaringologista /
 Distúrbios Respiratórios do Sono
 CRM-SP 130842